Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Assis

Rua Floriano Peixoto, 1616, fone balcão virtual - (55) 99682-7304 - Bairro: Centro - CEP: 97610000 - Fone: (55) 3029-9987 - Email: frsaofassvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000096-44.2024.8.21.0125/RS

AUTOR: GABRIELLE NOGUEIRA CHAVES

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

GABRIELLE NOGUEIRA CHAVES ajuizou ação em desfavor de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, ambos qualificados nos autos. Em síntese, alegou que é beneficiária de Plano de Assistência Médica, como usuária do IPÊSAÚDE, (matrícula nº 73.02369702.01.7, tendo sido diagnosticada com Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (CID G35). Relatou que precisa utilizar, com urgência, medicação *Ocrelizumab 600mg*, de forma semestral. Disse que, todavia, o tratamento foi negado pela ré. Requereu tutela provisória de urgência. Requereu AJG. No mérito, postulou a confirmação da tutela provisória, com o intento de obrigar a ré a fornecer a medicação Ocrelizumab 300mg, (2 frascos a cada 6 meses) (evento 1, INIC1). Juntou documentos.

Deferida a gratuidade judiciária (evento 4, DESPADEC1).

Sobreveio a Nota Técnica 191526 (evento 5, NOTATEC1).

Concedida a tutela provisória (evento 7, DESPADEC1).

Por sua vez, a ré ofereceu contestação. Em suma, argumentou que: a) qualquer medicamento a ser disponibilizado pelo IPE Saúde carece de previsão normativa inequívoca; b) a determinação de extensão da cobertura do IPE Saúde pela via judicial é situação que ofende o princípio constitucional da separação de Poderes; c) não é ambição do Sistema IPE Saúde garantir o atendimento para todo e qualquer atendimento de saúde de modo irrestrito (evento 19, CONT1). Juntou documento.

Houve réplica (evento 22, RÉPLICA1).

As partes demonstraram desinteresse em dilação probatória (evento 28, DOC1).

Intimado, o Ministério Público declinou da intervenção (evento 36, PARECER1).

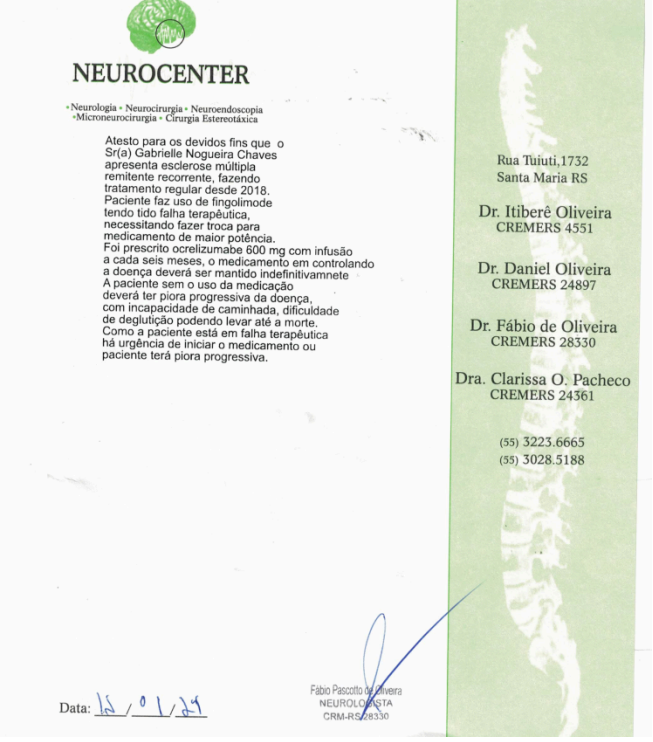
Vieram os autos conclusos para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, observa-se que a negativa administrativa do IPE Saúde (evento 1, OUT15) em fornecer o tratamento, através do uso da medicação postulada, baseou-se exclusivamente na alegação de que o medicamento não seria estaria abarcado pela cobertura do plano.

Por sua vez, segundo os laudos médicos juntados (evento 1, ATESTMED12 e evento 1, RECEIT13), a parte autora, apresenta esclerose múltipla remitente recorrente, com falha terapêutica na utilização de "Fingolimode", necessitando de substituição para a medicação "Ocrelizumabe".

Outrossim, referiu o médico que sem o uso da medicação Ocrelizumabe, a paciente teria piora progressiva da doença, acarretando incapacidade para caminhar, deglutição e até mesmo risco de morte:



NEUROCENTER

•Neurologia • Neurocirurgia • Neuroendoscopia
•Microneurocirurgia • Cirurgia Estereotáxica

Atesto para os devidos fins que o Sr(a) Gabrielle Nogueira Chaves apresenta esclerose múltipla remitente recorrente, fazendo tratamento regular desde 2018. Paciente faz uso de fingolimode tendo tido falha terapêutica, necessitando fazer troca para medicamento de maior potência. Foi prescrito ocrelizumabe 600 mg com infusão a cada seis meses, o medicamento em controlando a doença deverá ser mantido indefinitivamnete A paciente sem o uso da medicação deverá ter piora progressiva da doença, com incapacidade de caminhada, dificuldade de deglutição podendo levar até a morte. Como a paciente está em falha terapêutica há urgência de iniciar o medicamento ou paciente terá piora progressiva.

Rua Tuiuti,1732
Santa Maria RS

Dr. Itiberê Oliveira
CREMERS 4551

Dr. Daniel Oliveira
CREMERS 24897

Dr. Fábio de Oliveira
CREMERS 28330

Dra. Clarissa O. Pacheco
CREMERS 24361

(55) 3223.6665
(55) 3028.5188

Data: 12/01/24

Fábio Pascotto de Oliveira
NEUROLOGISTA
CRM-RS 28330

Disse, também, que o paciente tinha indicação de tratamento com o fármaco ocrelizumabe, **visto a falha terapêutica da medicação Fingolimode, exigindo a utilização de remédio mais potente, sob pena de agravamento do quadro clínico.**

Ainda, ressaltou o médico que o tratamento prescrito deveria ser iniciado com a maior brevidade possível, sob pena de piora adicional do quadro neurológico, com acúmulo de incapacidade irreversível e piora da qualidade de vida e da capacidade funcional, resultando em risco de morte.

Por tais razões, inclusive, que o pedido de tutela antecipada foi deferido.

Cumpre destacar que, em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar n.° 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde, revogando a Lei Complementar n.º 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Todavia, há que se conformar a interpretação de tal dispositivo com o direito de assistência à saúde previsto na Constituição Estadual (Art. 41-A. *O Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei*).

Nesse sentido, merece destaque o fato de que o fármaco postulado está incluído no rol de procedimentos de **cobertura mínima obrigatória** pelos planos de saúde privados, conforme a Resolução Normativa - RN nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Logo, não obstante o IPE Saúde seja regido pelas normas de direito público suprarreferidas e, portanto, não esteja sujeito à regulamentação editada pela ANS, **não faz nenhum sentido que o plano de assistência à saúde, oneroso, destinado aos servidores do Estado e seus respectivos dependentes, ofereça cobertura inferior à cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde privados, sob pena de não cumprir minimamente a sua função**.

É lícito ao réu promover a exclusão de tratamentos ou procedimentos, desde que o faça fundamentadamente, justificando as razões técnicas da negativa e com fundamento em evidências científicas ou demonstração cabal da insuportabilidade financeira da pretensão sanitária.

Escudar a negativa por falta de previsão nas suas tabelas e resoluções, sem justificativa, torna a garantia de assistência à saúde uma não-garantia, pois deixa ao arbítrio exclusivo da discricionariedade do administrador definir o que será fornecido. O servidor e seus dependentes ficam em total insegurança, visto que não têm qualquer ingerência na formulação das escolhas do administrador para a fixação de quais tratamentos serão ofertados.

A negativa só pode ser acolhida quando devidamente fundamentada, pois, assim não sendo, desconsidera a indicação do médico assistente, profissional com melhor capacidade de definir o melhor tratamento para o seu paciente.

Com efeito, não se pode ignorar a justificativa do médico quanto **à indicação da medicação postulada, fundada em evidências científicas.**

Por esse motivo, não merece acolhimento a alegação do demandado acerca da inexistência de evidências científicas do fármaco postulado para o tratamento da patologia.

Aliás, o laudo médico restou corroborados pela nota técnica número 191526 confeccionado pelo Departamento Médico Judiciário, a qual conclui favoravelmente pela indicação do medicamento Ocrelizumabe, nome comercial Ocrevus 600mg para o tratamento da moléstica que acomete a autora, bem como ressaltou a urgência em sua concessão para evitar a progressão da patologia com possível ocorrência de lesões de órgão ou comprometimento de função (evento 5, NOTATEC1):

Tecnologia: OCRELIZUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão:

CONSIDERANDO o diagnóstico de ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE, conforme dados médicos acostados ao processo.

CONSIDERANDO a eficácia comprovada em literatura médico-científica do OCRELIZUMABE na situação acima descrita.

CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS técnicos suficientes para suportar a indicação de OCRELIZUMABE no presente caso.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

Descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar prevista nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga, ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, visto que eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente para o caso concreto.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado, o que seria mister, já que, em última análise, a alegação é de que inexiste dotação orçamentária suficiente para tanto.

Ainda, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Assim, tenho que merece acolhimento a pretensão da parte autora.

III - DISPOSITIVO

Em razão do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **GABRIELLE NOGUEIRA CHAVES** contra o **Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde**, para tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória de tutela concedida no **Evento 7**.

A parte autora deverá apresentar receita atualizada diretamente ao réu, semestralmente, para que seja mantido o tratamento deferido, sob pena de desobrigatoriedade do réu continuar a fornecer a prestação de saúde deferida.

Condeno o IPE Saúde ao pagamento das custas processuais, isentas conforme previsão do art. 5º, inciso I, da Lei 14.634/14; bem como de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC/2015.

Em consonância com o **art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic**, a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015.

Decisão não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Caso interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades dos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do CPC/2015, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO MACEIS, Juiz de Direito**, em 07/01/2025, às 10:37:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10065895518v11** e o código CRC **f5f20135**.